

INDICADO POR: Dr. Ricardo Ottonino

() ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

MARIA CALDERARO DE AMORIM

viúva

IDADE: 72 PESO: 58 ALTURA: 1,53 PROFISSÃO: 50 km.

SINTOMAS: cefaleia matinal variada; tem AIT há +/- 15 dias.

reflexo; memória.

QUEIXAS: não dorme bem; Ronco; despertares; não mostra mais a noite

MEDICAMENTOS:

MÉDICO: Dr. Paulo Cardoso (Cardio); Dr. Ricardo (Ottonino)

MARCAPASSO: () S () N / COMPANHEIRO USAR MARCAPASSO: () S () N

EXERCÍCIO FÍSICO:

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: HORA QUE ACORDA:

COCHILHO () S () N DORME ACOMPANHADO: () S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: () S () N / DORMEM NO QUARTO: () S () N PET NO QUARTO: () S () N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA () N

FUMO: () S () MAÇO/DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO:

BANHEIRO/NOITE:

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP:

MALLAMPATI:

IAH: IDO: 34

SPO2: 75%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

() ORTOPÉDICA

(S) NEUROLÓGICA

() OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N

SPO2 C/ CPAP:

PRESSÃO NO EXAME:

22/07/25 Avaliação Auto 4 a 10 cmH₂O másc Dream Wisp29/07/25 P= 8,3 Percentil: 10 cmH₂O.

IAH= 4,3 e 1h

muro= 7h30'

fuogo= 28 l/min

Dito P. Fixa: 8,6 cmH₂O

Sinais

fluamper 5,0 cmH₂O

Polissonografia de noite inteira (inclui polissonogramas)

Exame do Sono Biologix®

Centro credenciado

centrocor - CENTROCOR

Paciente

Nome: Maria Calderaro de Amorim
Nascimento: 03/05/1953 (72 anos)
Sexo: Feminino

Telefone: +55 12 3923-1755

Exame

Início: 23/06/2025 - 22:25:49
Fim: 24/06/2025 - 02:36:03
Tempo total: 04:10:14 (250,2 min)
Tempo válido: 04:04:59 (245,0 min)

Condições na noite do exame

- ☐ Consumo de álcool
- ☐ Congestão nasal
- ☐ Sedativos
- ☐ Placa de bruxismo
- ☐ Marcapasso

Tratamentos na noite do exame

- ☐ CPAP
- ☐ Aparelho de avanço mandibular
- ☐ Terapia posicional
- ☐ Oxigênio
- ☐ Suporte ventilatório

Ficha médica

Medidas corporais
Respondido em 23/06/2025

Peso: 57 kg
Altura: 1,53 m
IMC: 24,3

Medicamentos

Respondido em 23/06/2025

- ☐ Levoid
- ☐ Janumet
- ☐ Aspirina
- ☐ Trezor
- ☐ Atenolol
- ☐ Neovangy

Sintomas

Respondido em 23/06/2025

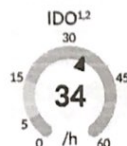
- ☐ Ronco alto e frequente
- ☐ Sonolência excessiva diurna
- ☐ Sono não reparador
- ☐ Despertares frequentes
- ☐ Engasgos noturnos
- ☐ Refluxo gastroesofágico
- ☐ Cefaleia matinal
- ☐ Dificuldade de concentração
- ☐ Perda de memória
- ☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil

Doenças associadas

Respondido em 23/06/2025

- ☐ Hipertensão arterial
- ☐ Diabetes
- ☐ Dislipidemia
- ☐ Câncer
- ☐ Depressão
- ☐ Arritmia cardíaca
- ☐ Infarto agudo do miocárdio
- ☐ Angina
- ☐ Insuficiência cardíaca
- ☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
- ☐ Bronquite / Enfisema
- ☐ Asma

Resultado



Valores de referência para o Índice de Dessat. de Oxigênio (IDO)

IDO < 5	Normal
5 ≤ IDO < 15	Apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30	Apneia do sono moderada
IDO ≥ 30	Apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia realizado no dia 23/06/2025, iniciado às 22:25 e terminado às 02:36. O tempo total de registro foi de 4h10min (250 minutos) e o tempo válido foi de 4h04min (244 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 140 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 34,3/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 92% e permaneceu abaixo de 90% durante 15% do tempo de registro (36 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 44% do tempo de registro.

A interpretação desses achados deve ser feita em conjunto com as informações clínicas complementares, anamnese, exame físico e resultados de outros exames.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono acentuada (IDO 34,3/hora), nas condições descritas. O tempo com SpO₂ abaixo de 90% é compatível com dessaturação significativa.

Dr. Pedro Rodrigues Gentia
CRM 87176-SP / RQE 48835-1

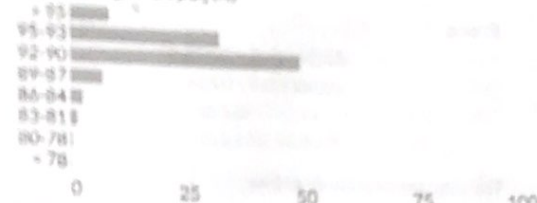
Dr. Paulo Cardoso
CRM 142290-SP / RQE 30259

Notas:

1. Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3% no nível de saturação de oxigênio (SpO₂).
2. O índice de dessaturações de oxigênio (IDO) corresponde ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.
3. Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 88% por 5 minutos consecutivos.
4. A correlação entre a carga hipóxica e o risco cardiovascular é baseada no artigo The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure (Azarbarzin et al. Chest. 2020; 158(2):739-750).

Ref.: 100-7275434CA

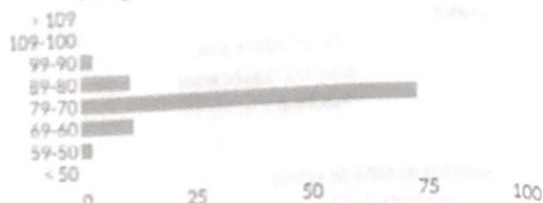
Polissonografia de noite inteira (inclui polissonogramas)

Oximetria (SpO₂)Histograma SpO₂ (%)

SpO ₂ mínima	75%
SpO ₂ média	92%
SpO ₂ máxima	98%
Tempo com SpO ₂ < 90%	36,9 min (15%)
Número de dessaturações ¹	140
Índice de dessaturações de oxigênio (IDO) ^{1,2}	34,3 /hora
Índice de dessat. de oxigênio sono (IDOs)	34,6 /hora
Número de eventos de hipoxemia ²	0
Tempo total em hipoxemia ³	0,0 min (0%)

Frequência cardíaca

Histograma frequência cardíaca (bpm)

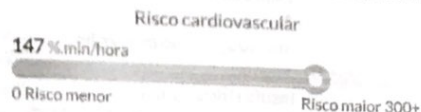


Mínima	52 bpm
Média	74 bpm
Máxima	107 bpm

Sono estimado

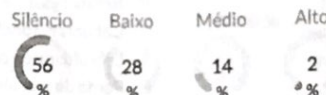
Tempo total de sono	204,5 min
Tempo para dormir	28,0 min
Tempo acordado pós-sono	15,5 min
Eficiência do sono	82%

Carga hipóxica - Hypoxic burden

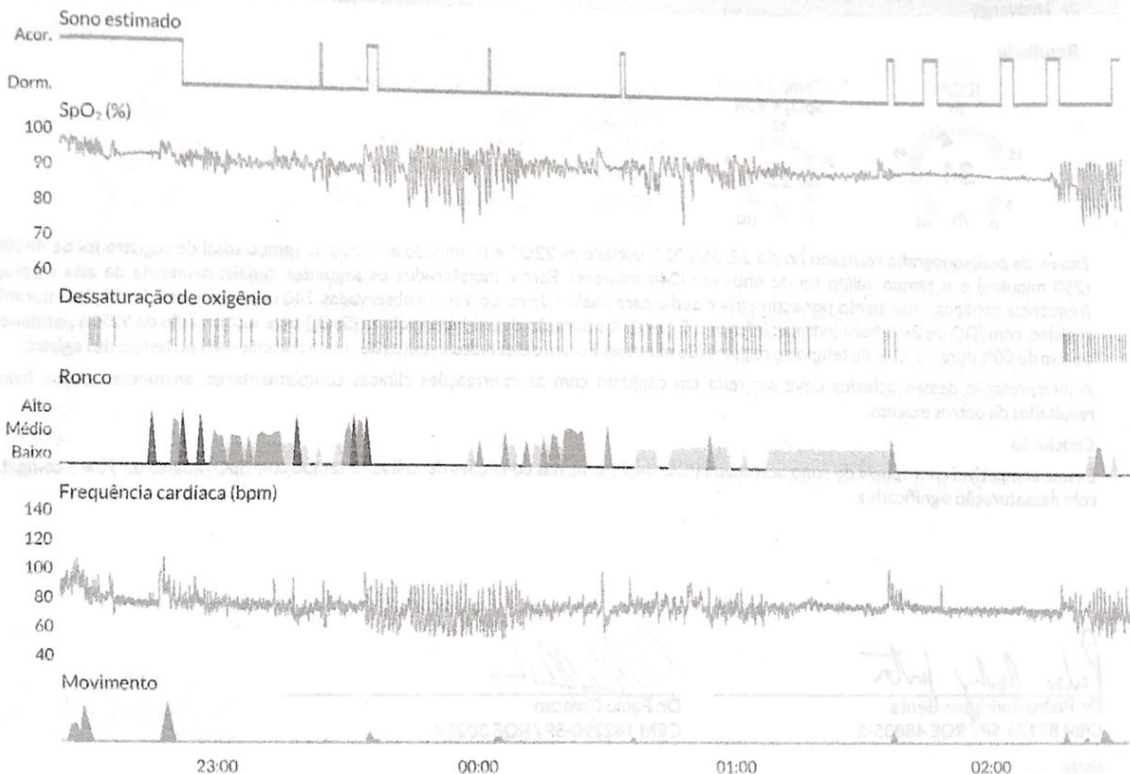
Carga hipóxica⁴ 146,9 %min /hora

Análise de ronco

Tempo de gravação	251,0 min
Tempo com ronco	110,4 min (44%)



Polissonogramas



Nº de série Oxistar 05628, versão do firmware 02.001.001

Aplicativo: plataforma android, versão 2/1.12.8

Processamento: examprocserver-1.7.14, examreport-1.2.5

Documento gerado em 24/06/2025 às 10:06:03 BRT

PCE. 100-71070-000000